住　院　记　录

姓名：于文才　　性别：男　　年龄：69岁　　科室：内科综合　　床位：13-30　　住院号：201909421

姓　名：于文才	职　　业：退（离）休人员
性　别：男	出 生 地：黑龙江省大庆市龙凤区
年　龄：69岁	病史陈述：患者本人
民　族：汉族	可靠程度：可靠
婚　姻：已婚	住院日期：2019-11-18 14:55:53
住　址：黑龙江省大庆市龙凤区龙八路25号2门501室	记录日期：2019-11-18 16:35:06

主诉：　右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天。

现病史：患者于5天前，无明显诱因出现右侧肢体麻木不适感，麻木呈持续性，无头晕、头痛，无肢体活动不灵，活动后麻木无减轻，因症状较轻，未给予重视，入院前2天，晨起时自觉麻木较前加重，且伴明显头晕、头沉不适，频繁呛咳，右侧肢体无力感，右手持物不稳，穿衣时右侧肢体活动欠灵，走路右腿拖地且步态不稳，右侧肢体有明显发凉感，无意识不清，无抽搐发作，无视物旋转，无恶心呕吐，充分休息后上症未见好转。今日为求系统治疗前来我就诊，门诊检查后以“腔隙性脑梗塞”收入院。平素饮食、睡眠尚可，二便正常。

既往史：高血压病病史10年，血压最高可达：160/110mmHg，现规律口服替米沙坦片，未监测血压；脑梗塞病史9年，遗留言语含糊不清，饮水时有呛咳，行走缓慢，规律口服阿司匹林肠溶片、他汀类药物控制病情。否认糖尿病、冠心病等病史；否认肝炎、结核等传染病病史；未发现药物、食物等过敏史；否认手术、外伤史。

个人史：患者生于我省，否认、疫水、疫区、疫源等接触史。

婚姻史：适龄婚育，配偶及子女身体健康。

家族史：否认家族性、遗传性、传染性等病史。

以上病史记录经陈述者确认无误并签字：

体　　格　　检　　查

体温：36.5℃　脉搏：70次/分　呼吸：20次/分　血压：130/90mmHg

一般状态欠佳，发育正常，营养中等，慢性病容，神志清，轮椅推入病室，查体合作。

皮肤粘膜：全身皮肤粘膜完整，无黄染、皮疹、出血点，无肝掌、蜘蛛痣。

浅表淋巴结：颏下、颌下、颈前、耳前、耳后、枕后、锁骨上、锁骨下、腋窝及腹股沟淋巴结无肿大。

头颅及五官：

头颅：无畸形，头发浓密，分布均匀。

眼：无脱眉、倒睫，双眼睑无浮肿，睑结膜无苍白，巩膜无黄染，球结膜无水肿，眼球无突出，运动自如，双侧瞳孔等大等圆，直径约3mm，对光反射灵敏。

耳：双耳听力正常，外耳道无分泌物，耳廓及乳突无压痛。

鼻：通畅，鼻中隔无偏曲，鼻翼无扇动，鼻窦区无压痛，无流涕、出血。

口腔：唇色无苍白，牙龈无红肿，舌苔白薄，伸舌无偏斜，咽部无充血，双侧扁桃体无肿大。

颈部：两侧对称，无颈强直，颈静脉无怒张，颈动脉无异常搏动，气管居中，甲状腺无肿大。

胸部：胸廓无畸形，呼吸节律规整，双侧乳房对称。

肺脏：

视诊：双侧呼吸运动两侧对称。

触诊：双侧呼吸运动度均等，语颤无增强，无胸膜摩擦感。

叩诊：呈清音，肺下界为于左锁骨中线第五肋间，左肩胛线第十肋间，右肩胛线第九肋间，移动度6-8cm。

听诊：双肺呼吸音清，未闻及干湿性啰音，未闻及胸膜磨擦音。

心脏：

视诊：心前区无隆起，心尖搏动位于左侧第五肋间左锁骨中线内0.5cm，搏动范围直径约1.5cm。

住　院　记　录

姓名：于文才　性别：男　年龄：69岁　科室：内科综合　床位：13-30　住院号：201909421

触诊:心尖部无震颤、摩擦感、抬举样搏动。
叩诊：心界不大,心脏相对浊音界如下：

右侧（cm）	肋间	左侧（cm）
2.0	Ⅱ	2.5
3.0	Ⅲ	3.5
3.5	Ⅳ	6.0
	Ⅴ	7.5

左锁骨中线距前正中线8.0cm
听诊：心率：70次/分，心律齐，第一心音无增强，各瓣膜区未闻及病理杂音和心包摩擦音。
桡动脉：搏动有力，节律整齐，无水冲脉或脉搏短绌、水冲脉，血管弹性正常，脉率：70次/分。
周围血管征：无毛细血管搏动征和枪击音。
腹部：
视诊：腹部无膨隆，未见腹壁静脉曲张及蠕动波。
触诊：腹软，剑突下无压痛，无反跳痛，肝脾肋下未触及。无液波震颤。未触及包块。
叩诊：轻度鼓音，移动性浊音阴性，肝浊音界存在，双肾区无叩击痛。
听诊：肠鸣音4次/分，未闻及气过水声及血管杂音。
肛门及生殖器：未查。
脊柱、四肢：无畸形，关节无红肿，双下肢无浮肿。四肢功能见神经科检查。
神经系统：见专科检查。

专科检查

意识清楚，言语欠流利，记忆力减退，计算力、定向力正常，查体合作；双侧额纹对称，双侧瞳孔等大同圆，对光反射灵敏，双眼位居中，眼球运动充分，无眼震，双侧鼻唇沟无变浅，伸舌居中，悬雍垂居中，软腭上抬充分；右上肢肌力4+级、肌张力正常，右下肢肌力4+级、肌张力正常，左侧肢体肌力、肌张力正常；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退，双侧深感对称存在；右侧Babinski征、Chaddock征阴性，颈强（-）、克氏征阴性。

实验室及器械检查(重要的化验X线等检查)

辅助检查：头颅CT（2019-11-20 本院 CT号：17294）：双侧基底节、放射冠区见点状低密度影，边缘模糊，大小不超过1.0cm，脑沟增宽，第三脑室以上脑室系统扩张，脑干似见点状低密度影，影像诊断：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

摘　　要

患者因“右侧肢体麻木5天，伴肢体无力2天”入院。高血压病病史10年；脑梗塞病史9年。查体：体温：36.5℃ 脉搏：70次/分 呼吸：20次/分 血压：130/90mmHg；神经系统检查：意识清楚，言语欠流利，记忆力减退；右上肢肌力4+级，右下肢肌力4+级；右侧指鼻试验欠稳准，右侧跟膝胫试验欠稳准；右侧温度觉减退。辅助检查：头颅CT：腔隙性脑梗塞 可疑脑干低密度影，建议必要时MRI检查 脑萎缩。

临床确定诊断

腔隙性脑梗塞
脑梗塞后遗症期
高血压病

主治医生：　王雪峰

日期：2019年11月19日

临床初步诊断：

腔隙性脑梗塞
脑梗塞后遗症期
高血压病

住院医生：　王科英/　樊庆欢

日期：2019年11月18日